

- 13★★★★
☑☑☑ 胸水中の中性脂肪が 110 mg/dL 超の場合は乳び胸と診断される。
- 14★★★★
☑☑☑ 胸水中の糖が 60 mg/dL 未満となる疾患として慢性関節リウマチ随伴性胸水がある。
- 15★★★★
☑☑☑ 胸水中の好酸球増加は寄生虫や薬剤性胸水を示唆し、結核性や癌性を否定する所見である。
- 16★★★★
☑☑☑ 胸水中の adenosine deaminase (ADA) 上昇は結核性胸膜炎の検査所見として特異度が高い。
- 17★★★★
☑☑☑ 肺外結核の中ではリンパ節結核について結核性胸膜炎が多い。
- 18★★★★
☑☑☑ 結核性胸膜炎では胸水の塗抹による結核菌検出の感度が高いため、積極的に胸腔鏡検査を行う必要性は低い。
- 19★★★★
☑☑☑ 結核性胸膜炎は一次結核よりも二次結核で高頻度にみられる。
- 20★★★★
☑☑☑ 結核性胸膜炎はフィブリンが豊富で治療が遅れると拘束性換気障害の原因となる。
- 21★★★★
☑☑☑ 胸水中の好中球が優位の細胞増加がみられれば、結核性胸膜炎は否定的と考えられる。
- 22★★★★
☑☑☑ 膠原病の中では全身性エリテマトーデスと慢性関節リウマチが高頻度に胸膜炎を合併する。
- 23★★★★
☑☑☑ 慢性膿胸の合併症として Epstein - Barr ウイルス感染の関与するリンパ腫がある。
- 24★★★★
☑☑☑ 胸水検査における pH の低値 (7.2 未満)、糖濃度低下 (40 mg / dL 未満) は膿胸の予後不良因子である。
- 25★★★★
☑☑☑ 膿胸において、胸膜の癒着や胸腔内の隔壁形成によりドレナージが不十分な場合は、早期に胸膜搔爬術を検討する。
- 26★★★★
☑☑☑ 特発性血気胸は壁側と臓側胸膜の異常血管の破綻が原因であることが多い。
- 27★★★★
☑☑☑ 特発性血気胸は肺底部胸膜に多くみられる。
- 28★★★★
☑☑☑ 少量胸水の存在診断には Point of care Ultrasound が有用であり、その診断感度は聴診、胸部単純 X 線よりも高い。